

Nutrição em Pediatria

Benefícios do Aleitamento Materno

Primeiramente, vale lembrar que os benefícios do aleitamento materno são amplos e atingem tanto o bebê quanto a mãe, ou seja, beneficiam todo o **binômio mãe-bebê**.

Para o bebê, os ganhos são impressionantes: temos uma redução significativa de quadros infecciosos, principalmente **diarreia e infecções respiratórias**, que são causas importantes de internação e morbimortalidade infantil. Além disso, há diminuição do risco de **alergias** e redução do risco futuro de desenvolver **obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia** na vida adulta. O leite materno também auxilia na **mielinização** do sistema nervoso central e no **desenvolvimento neurovisual**, graças à presença de ácidos graxos de cadeia longa como o DHA e o ARA. É importante destacar ainda que o leite materno é o alimento mais completo que existe para o lactente. Quando comparamos bebês que mamam no peito com aqueles que usam mamadeira, percebemos que as crianças amamentadas apresentam melhor **desenvolvimento orofacial**, com melhor padrão de sucção e oclusão dentária.

Para a mãe, os benefícios também são significativos: há redução da incidência de **câncer de mama, endométrio e ovário**. Durante o período de **amenorreia lactacional** em aleitamento materno exclusivo (que pode durar até aproximadamente 6 meses), existe um efeito contraceptivo natural. Além disso, o aleitamento materno tem baixo custo financeiro e promove maior **vínculo afetivo** entre mãe e bebê, fortalecendo essa relação tão importante.

Modalidades de Aleitamento Materno

Precisamos entender que existem diferentes modalidades de alimentação do lactente, e é fundamental conhecê-las para orientar adequadamente às famílias.

O **aleitamento materno exclusivo (AME)** é aquele em que o bebê recebe apenas leite materno direto da mama ou ordenhado, sem nenhum outro líquido ou sólido. Podem ser administradas apenas vitaminas, suplementos minerais ou medicamentos, quando indicados. Esta é a **modalidade recomendada até os 6 meses de idade**. Após esse período, deve-se iniciar a alimentação complementar, mantendo o aleitamento materno até pelo menos os dois anos de vida ou mais.

O **aleitamento materno misto ou parcial** acontece quando a criança recebe leite materno associado a outros tipos de leite, como fórmulas à base de leite de vaca ou de cabra. Essa modalidade não é ideal, mas às vezes se torna necessária por diversas razões.

O **aleitamento materno predominante**, que não é recomendado, ocorre quando além do leite materno a criança recebe outros líquidos como água, chás ou sucos. O problema aqui é que esses líquidos ocupam espaço no pequeno estômago do bebê, reduzindo a ingestão de leite materno, além de poderem ser uma fonte de contaminação e infecção.

O **aleitamento materno complementado** é a modalidade ideal após os 6 meses: o leite materno continua sendo oferecido, mas associado à alimentação complementar sólida. Essa fase deve se estender até pelo menos os dois anos de vida da criança.

Pegadinha comum de prova: As bancas adoram perguntar sobre a duração do aleitamento materno exclusivo e complementar. Grave: **AME em livre demanda até 6 meses; complementar até no mínimo 2 anos.**

Comparação: Leite Materno versus Leite de Vaca

É fundamental entender as diferenças na composição entre o leite materno e o leite de vaca para compreender por que o leite humano é tão superior para o bebê.

Em relação às **proteínas**, o leite materno possui menor quantidade total, principalmente de **caseína**, sendo mais rico em **alfa-lactoalbumina**. Já o leite de vaca contém **beta-lactoglobulina**, uma proteína altamente alergênica. Essa menor quantidade de proteínas no leite materno é vantajosa porque resulta em menor **sobrecarga renal** para os rins ainda imaturos do lactente. Outro componente importante é o **sódio**: o leite materno possui menos sódio, contribuindo ainda mais para essa menor sobrecarga renal.

Quanto à **lactose**, o leite materno possui maior concentração, o que ajuda no **trânsito intestinal** e resulta em menos constipação intestinal. É por isso que bebês que mamam no peito tendem a evacuar com mais frequência e fezes mais amolecidas.

Outra diferença marcante está no teor de **gorduras**: o leite materno é mais rico em gorduras, especialmente em **ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa** (como DHA e ARA), que são essenciais para a mielinização do sistema nervoso e formação da retina. Além disso, o leite materno possui **lipase** em sua própria composição, uma enzima que é ativada ao entrar em contato com os ácidos biliares no intestino da criança. Ou seja, o leite materno já fornece tanto a matéria-prima (gordura) quanto a enzima para digeri-la.

O leite materno também apresenta maior **biodisponibilidade de ferro**, graças à presença da **lactoferrina**, uma proteína que facilita a absorção desse mineral essencial. Além disso, possui mais fatores de proteção imunológica, especialmente **imunoglobulina A (IgA)**. Por outro lado, o leite de vaca é deficiente em **vitaminas A, D e C**, o que reforça ainda mais a superioridade do leite materno.

Modificações do Leite Materno

A produção de leite não é uniforme: ela oscila em diferentes períodos, fases do desenvolvimento e até horários do dia. Entender essas variações é fundamental para orientar as mães adequadamente.

Em relação às **fases da lactação**, temos primeiro o **colostro**, produzido do terceiro ao quinto dia de vida do recém-nascido. O colostro possui mais **proteínas, eletrólitos e vitamina A**, apresentando uma coloração mais amarelada e consistência mais fluida. Depois vem o **leite de transição**, que representa a fase intermediária entre o colostro e o leite maduro. O **leite maduro** é produzido a partir da segunda semana de vida e é mais esbranquiçado, devido ao maior teor de **gorduras e lactose**.

Durante uma mesma mamada também há variação: no início, sai o **leite anterior**, que é mais aquoso e rico em **proteínas e lactose**. Ao final da mamada, vem o **leite posterior**, que é mais gorduroso e traz maior **saciedade** para o bebê. É exatamente por causa dessa diferença de composição que precisamos orientar a mãe a **esvaziar completamente uma mama antes de trocar para a outra**. Se a mãe trocar de mama muito rapidamente, o bebê receberá apenas o leite anterior de ambas as mamas, ficando sem o leite posterior mais calórico e gorduroso.

Ao longo do dia também há modificações: o leite produzido à noite possui maior teor de **gordura**, enquanto pela manhã tem menos.

Por fim, há modificação de acordo com a **idade gestacional** do bebê: as mães de prematuros produzem leite com mais **gordura, proteína, calorias, IgA, lactoferrina, vitaminas A e E, e eletrólitos** (exceto potássio). É incrível como o organismo materno se adapta às necessidades específicas do bebê prematuro.

Fisiologia da Lactação

Para entender como orientar as mães adequadamente, precisamos dominar a fisiologia da produção de leite. A lactação é dividida em três fases distintas:

Fase 1 - Durante a gestação: Sob influência do **estrogênio e progesterona**, ocorre o desenvolvimento dos **alvéolos mamários**, que são as estruturas produtoras de leite. Esse processo acontece durante toda a gestação, preparando a mama para a lactação.

Fase 2 - Pós-parto imediato: Com a saída da placenta, há remoção do principal sítio de produção dos hormônios que controlam a ação da **prolactina**, especialmente a **progesterona** e o **lactogênio placentário** (hormônios inibitórios). Ao retirar a placenta, caem os níveis desses hormônios inibidores e a prolactina finalmente consegue agir. Essa fase não depende do estímulo do bebê, não depende da sucção. A **apojadura**, que é a "descida do leite", ocorre entre o terceiro e quinto dia de nascimento e marca o fim dessa fase.

Fase 3 - Galactopoeise: Esta fase perdura durante todo o processo de amamentação do bebê. É um processo totalmente **dependente do estímulo da sucção e do esvaziamento** das mamas. Funciona como um ciclo: quanto mais o bebê mama, mais leite é produzido.

Entendendo o diagrama da lactação: tudo começa com o **estímulo tátil** do bebê ao sugar a mama. Essa sucção estimula o eixo **hipotálamo-hipófise**, que libera **ocitocina e prolactina** na corrente sanguínea até chegarem às glândulas mamárias. Cada hormônio tem um efeito diferente: a **prolactina** controla a **produção de leite** pelos alvéolos mamários; já a **ocitocina** controla a **contração das células musculares** ao redor dos alvéolos, promovendo a ejeção do leite.

Para onde vai esse leite? Dos alvéolos, ele vai para os **ductos lactíferos**, que se juntam nos **seios lactíferos**, onde ficam armazenados temporariamente, até irem à boca do recém-nascido por meio da sucção, criando assim um ciclo contínuo. Se a

mama não for esvaziada adequadamente, ocorre queda do estímulo e consequente redução da produção de leite.

Gatilho para prova: O principal mecanismo que leva a uma boa produção de leite materno é o **estímulo à sucção e esvaziamento da mama**.

Armazenamento do Leite Materno

Quando a mãe não pode amamentar diretamente, precisamos orientar sobre o correto armazenamento do leite ordenhado. O leite pode ser mantido na **geladeira por até 12 horas** e no **congelador por até 15 dias**.

Mnemônico para guardar: Armazenamento de leite materno: **geladeira - meio dia; congelador - meio mês**.

Os cuidados são fundamentais: **não deixar na porta** da geladeira ou congelador, pois há maior variação de temperatura; usar **frasco de vidro com tampa plástica**; fazer aquecimento em **banho-maria** para ter um aquecimento uniforme (nunca usar micro-ondas, pois pode criar pontos muito quentes que queimam a boca do bebê); preferencialmente oferecer em **copinho** para evitar confusão de bicos; **datar os frascos** para controlar a validade; **não recongelar** leite descongelado e **não reutilizar sobras** descongeladas.

Técnica de Amamentação

A técnica correta de pega e posicionamento é fundamental para o sucesso da amamentação. Se for feita de maneira incorreta, podemos ter complicações como fissuras mamárias ou ganho de peso inadequado do bebê.

Para um **posicionamento correto**, observe: o rosto do bebê deve estar de frente para a mama; o pescoço deve estar alinhado com o tronco (pescoço não torcido); o corpo do bebê deve estar bem junto ao da mãe; e o bebê precisa estar bem apoiado.

Quanto à **pega adequada**, o bebê deve abocanhar a **aréola**, não apenas o mamilo. Se sobrar aréola visível, deve sobrar **em cima** (acima da boca), não embaixo. A boca deve estar **bem aberta**, o **lábio inferior evertido** (virado para fora), o **queixo tocando a mama** e, quando possível, o **nariz livre**.

Pense na pega como uma "boca de peixe" - bem aberta, abocanhando o máximo possível da aréola, não apenas "beliscando" o mamilo.

Dificuldades na Amamentação

Nossa função é reconhecer precocemente os fatores de risco que levam às complicações e saber conduzi-las adequadamente.

A **fissura ou trauma mamilar** quase sempre decorre de **pega inadequada**, quando o bebê abocanha apenas a ponta do mamilo em vez da aréola. A mulher relata dor importante durante as mamadas e podemos observar fissuras ou até sangramento no mamilo. A conduta é **manter o aleitamento, corrigir a técnica de pega e manter os mamilos secos** após as mamadas.

O **ingurgitamento mamário** aparece quando a mama fica muito cheia, edemaciada, com pele brilhante e muito dolorosa. O principal fator de risco é o **esvaziamento inadequado** da mama, levando ao acúmulo de leite, congestão e piora da drenagem linfática. É essencial diferenciar esse quadro do fenômeno fisiológico da apojadura. A condução passa por manter o aleitamento, fazer **ordenhas de alívio** (inclusive antes da mamada para facilitar a pega, pois a mama muito tensa dificulta a pega correta) e, após mamar, usar **compressas frias** para reduzir o edema.

A **mastite** é um processo inflamatório, que pode ou não ter infecção bacteriana associada, acometendo um ou mais segmentos da mama. O leite estagnado do engurgitamento e as fissuras mamárias funcionam como porta de entrada para bactérias. O principal agente é o **Staphylococcus aureus**, e as fissuras representam a principal porta de entrada. Clinicamente, além de dor, edema, hiperemia e calor local, é comum haver **febre**. O tratamento consiste em **manter o aleitamento**,

esvaziar a mama adequadamente e **introduzir antibioticoterapia** quando indicado (exemplos: cefalexina ou amoxicilina-clavulanato). Se evoluir para **abscesso mamário**, existe divergência de condutas a depender da fonte consultada. Segundo o Ministério da Saúde, devemos **suspender o aleitamento apenas na mama afetada**, realizar **drenagem cirúrgica** e tratar com antibioticoterapia. Depois de resolvido o abscesso, retoma-se o aleitamento normalmente. Já segundo a FEBRASGO, caso os sintomas da mãe permitam, pode-se manter o aleitamento na mama afetada, tendo em vista que **não é uma contraindicação absoluta**. O importante é sempre lembrar de **manter a amamentação**, mesmo que só na mama sadia por um tempo, para evitar desmame precoce!

Segundo dia pós-parto com dor mamilar? Pense em **fissura mamilar**. Qual a principal causa? **Pega inadequada**.

Gatilho: O principal mecanismo que leva ao aparecimento das fissuras mamilares é a **pega inadequada**.

Contra Indicações ao Aleitamento Materno

Precisamos conhecer as situações em que o aleitamento materno está contraindicado, seja por causas maternas ou causas relacionadas ao próprio bebê.

Causas Maternas

Em relação às causas maternas, geralmente são **infeciosas ou medicamentosas**.

Sobre as **infecções**: o **HIV** permanece como contraindicação nas diretrizes usuais de prova, apesar de discussões recentes sobre a possibilidade de amamentação com carga viral indetectável e uso de antirretrovirais. O **HTLV** também contraindica a amamentação. Infecção aguda por CMV: contraindicado se o RN for <30-32 semanas. Quanto aos **medicamentos**, alguns impedem o aleitamento: **amiodarona, lítio, ganciclovir, radiofármacos** e certos **quimioterápicos**.

Na **tuberculose**, se a mãe for **bacilífera** ou tiver menos de duas semanas de tratamento, mantém-se o aleitamento, mas com uso de máscara e higiene rigorosa. Se houver **mastite tuberculosa**, suspende-se a amamentação até a mãe não ser mais bacilífera.

Na **COVID-19**, mantém-se a amamentação com uso de **máscara**. A **varicela** recente contraindica temporariamente. **Hepatites B e C não contraindicam** a amamentação, apesar do risco teórico de transmissão.

O **uso crônico de drogas ilícitas** contraindica completamente o aleitamento; com uso esporádico, suspende-se enquanto durar o efeito da substância. Com **álcool**, para cada dose ingerida, aguarda-se cerca de **duas horas** antes de amamentar.

Causas Relacionadas ao Bebê

Há duas contraindicações clássicas relacionadas ao bebê: **galactosemia** e **fenilcetonúria**.

Na **galactosemia**, a amamentação é **absolutamente contraindicada**. Ocorre deficiência da enzima **GALT**, impedindo o metabolismo da galactose, que se acumula no organismo e pode causar **icterícia, catarata ou sepse por E. coli**. Esses lactentes recebem **fórmula sem lactose e sem origem animal**, como as fórmulas à base de soja.

Na **fenilcetonúria**, a amamentação pode ocorrer de **forma restrita**, ou seja, não é livre demanda. Nesta doença há deficiência da enzima **fenilalanina hidroxilase**, provocando acúmulo de fenilalanina principalmente no sistema nervoso central, podendo evoluir com **deficiência intelectual**. Essa criança receberá aleitamento materno restrito (em pequenas quantidades controladas), complementado por fórmula especial sem fenilalanina.

Em relação ao **CMV fetal**, em prematuros menores que 1.500 g ou com menos de 30 semanas, deve-se usar **leite materno pasteurizado** para inativar o vírus.

Fórmulas Infantis

As fórmulas infantis são os únicos alimentos reconhecidos como alternativa adequada ao leite materno quando a amamentação não é possível. Elas são divididas em dois segmentos: as **fórmulas de partida (número 1)**, indicadas de zero a seis meses; e as **fórmulas de seguimento (número 2)**, indicadas de seis meses a um ano.

Importante: Acima de um ano, não há mais indicação de manutenção de fórmula. O **leite de vaca** já está liberado para essas crianças. A diluição padrão das fórmulas costuma ser de **1 para 30**, ou seja, um medidor para 30 ml de água, mantendo-se essa proporção: dois medidores para 60 ml, três para 90 ml e assim por diante.

Fórmulas Especiais para APLV

As fórmulas especiais são indicadas para pacientes com **alergia à proteína do leite de vaca (APLV)**, um quadro que pode ter manifestações muito variadas: vômitos, diarreia (com ou sem sangue), refluxo gastroesofágico e alterações cutâneas. Dependendo da apresentação clínica e do mecanismo imunológico da APLV, indicamos um tipo específico de fórmula.

As **fórmulas à base de proteína de soja** são a primeira opção para bebês **acima de seis meses** com APLV **mediada por IgE** (reação imediata) ou **sem comprometimento gastrointestinal**.

Quando há **envolvimento do trato gastrointestinal** ou em **menores de seis meses**, indicam-se as **fórmulas extensamente hidrolisadas**. Essas fórmulas também são utilizadas quando não há boa resposta à proteína de soja.

As **fórmulas à base de aminoácidos** são totalmente não alergênicas e representam a última linha de tratamento, indicadas para crianças com **alergias múltiplas, má absorção grave** ou **falha nas demais opções**.

Introdução Alimentar

A introdução alimentar deve ser iniciada idealmente aos **seis meses de vida**, quando a criança já apresenta os **sinais de prontidão**: consegue permanecer sentada com apoio e perdeu o **reflexo de protrusão da língua** (que expulsava alimentos sólidos da boca).

Iniciamos aos seis meses com **uma refeição principal** (almoço ou jantar, conforme a rotina familiar) e **uma fruta**. Com sete meses, acrescentamos mais uma refeição principal e outra fruta, totalizando **duas refeições e duas frutas por dia**.

Desde o início, a criança deve receber alimentos de **todos os grupos nutricionais**. A oferta deve ser feita seguindo o esquema do "**pratinho**": metade composta por **hortaliças, legumes e verduras**; um quarto de **cereais e tubérculos** (batata, arroz, macarrão); e o quarto restante de **proteínas**, sendo metade de origem animal (peixe, carne bovina, suína ou ovo) e metade de origem vegetal (feijão, ervilha, grão-de-bico). Pode-se oferecer uma fruta como sobremesa.

Preparo dos Alimentos

Os alimentos devem ser oferecidos **separadamente** no prato, para que a criança reconheça o sabor e a textura de cada um. Inicialmente devem ser **cozidos e amassados com o garfo**, com progressão gradual da textura até que, por volta de **um ano de idade**, a criança coma a mesma comida da família. **Não se deve liquidificar ou peneirar** os alimentos. Deve-se priorizar **frutas inteiras** em vez de sucos, além de alimentos **in natura ou minimamente processados**.

Contraindicações na Introdução Alimentar

Entre as contraindicações, destacam-se: **não adicionar sal ou mel antes de um ano de idade** (pode-se usar temperos naturais como cebola, alho, orégano, manjeriço); **evitar açúcar e ultraprocessados antes dos dois anos**. Deve-se **respeitar o ritmo da criança**, sem forçar a alimentação. O objetivo inicial é explorar sabores, não necessariamente ingerir grandes quantidades. É preciso introduzir

progressivamente os alimentos para que a criança vá se interessando gradualmente.

Janela Imunológica

Sobre a **janela imunológica**, deve-se introduzir precocemente alimentos **potencialmente alergênicos** — ovo, amendoim, camarão, castanhas — **a partir do sexto mês**, pois isso reduz o risco de desenvolvimento de alergias no futuro. Essa recomendação mudou nos últimos anos: antes se recomendava evitar esses alimentos, hoje sabemos que a introdução precoce é protetora.

A criança pode e deve **ingerir água normalmente**, de preferência em vez de sucos ou bebidas açucaradas.

Método BLW (Baby-Led Weaning)

O método BLW, ou desmame guiado pelo bebê, consiste em oferecer os alimentos em **pedaços, tiras ou bastões**, para que a criança os explore e coma sozinha, usando as mãos. A **Sociedade Brasileira de Pediatria não o recomenda como método exclusivo** de alimentação complementar, pois não há evidências e trabalhos publicados em quantidade e qualidade suficientes para afirmar que o método seja a única forma correta de introdução alimentar.

A SBP recomenda que o bebê receba **alimentos amassados oferecidos na colher**, mas também receba **alimentos inteiros com as mãos**, visando explorar as diferentes texturas, formas e temperaturas como parte natural do seu aprendizado sensório-motor. Dessa forma, o bebê pode tanto ser alimentado pela mãe ou cuidador quanto explorar os alimentos com as mãos, favorecendo o desenvolvimento neurológico e sensorial de forma equilibrada.

Seletividade Alimentar

A **seletividade alimentar** ocorre quando a criança passa a recusar alimentos, apresentando falta de apetite ou desinteresse pela comida. Na maioria das vezes, isso se deve a uma **introdução alimentar inadequada**: oferta de alimentos repetitivos e sem variedade; alimentos ricos em açúcar; alimentos oferecidos em contextos de distração como TV e celular; ausência de momento de refeição bem delimitado; falta de refeições em família.

Há distúrbios neurológicos que podem estar associados à seletividade alimentar maior, principalmente relacionados a texturas e sabores (como no Transtorno do Espectro Autista), mas a maioria dos casos decorre de introdução alimentar errada.

É importante diferenciar seletividade alimentar de **neofobia**, que é um fenômeno normal que ocorre entre **18 e 24 meses** de idade, em que a criança passa temporariamente a rejeitar alimentos novos, querendo apenas alimentos específicos e conhecidos. A neofobia é um processo **autolimitado** e faz parte do desenvolvimento normal.

Intervenções para Seletividade Alimentar

As intervenções possíveis incluem: manter **horários definidos** para as refeições; realizar refeições **à mesa, em família**, para que as crianças entendam o momento da refeição; **oferecer o mesmo alimento de oito a dez vezes** antes de considerar que houve rejeição definitiva; **variar o modo de preparo** (por exemplo, cenoura em bastão, ralada ou em rodelas) para despertar o interesse da criança; **respeitar sinais de fome e saciedade**; **evitar barganhas** do tipo "só se comer ganha sobremesa"; e **não usar distrações** durante a refeição (nada de TV, tablet ou celular).

Suplementação de Micronutrientes

Suplementação de Ferro

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, o ferro deve ser ofertado de forma profilática conforme **idade gestacional, peso ao nascer e fatores de risco** para anemia.

Crianças a termo (mais de 37 semanas) e peso acima de 2.500 g recebem **1 mg/kg/dia de ferro elementar** (atenção: o cálculo é sempre baseado no ferro elementar, não no sulfato ferroso total). Os **fatores de risco para anemia** são: mãe com anemia gestacional, perdas sanguíneas durante o parto, clampeamento imediato do cordão umbilical e doenças disabsortivas. Se a criança tiver algum desses fatores de risco, inicia-se a suplementação aos **três meses** de vida até os **dois anos**. Se não tiver fator de risco, começa aos **seis meses**, mantendo até os dois anos.

Prematuros (menos de 37 semanas) ou com peso inferior a 2.500 g iniciam a suplementação aos **30 dias de vida** até os **dois anos**. No **primeiro ano** de vida, a dose depende do peso ao nascer:

- Menores de 1.000 g: **4 mg/kg/dia**
- Entre 1.000 e 1.499 g: **3 mg/kg/dia**
- Entre 1.500 e 2.499 g: **2 mg/kg/dia**
- No **segundo ano**, a dose é sempre **1 mg/kg/dia**, independentemente do peso ao nascer.

Quando há **anemia instalada**, não se trata mais de profilaxia, mas sim de tratamento. A dose terapêutica passa a ser de **4 a 6 mg/kg/dia de ferro elementar**.

Pegadinha de prova: Existe a **anemia fisiológica do lactente**, que ocorre entre **dois e três meses** de vida, devido à queda fisiológica transitória da produção de eritropoetina. É importante saber que a hemoglobina pode cair para valores em torno de 11 g/dL sem que isso represente doença. Esse quadro não tem sintomas, não requer tratamento com doses terapêuticas, apenas manutenção da suplementação profilática habitual. Resolve-se espontaneamente.

Suplementação de Vitamina D

A suplementação de vitamina D é **universal** e mais simples: inicia-se no **sétimo dia de vida**, com **400 UI/dia** no primeiro ano e **600 UI/dia** no segundo ano. Todos os bebês devem receber, independentemente do tipo de alimentação ou exposição solar.

Gatilho: Suplementação de vitamina D inicia-se sempre no **sétimo dia de vida**: **400 UI/dia no primeiro ano e 600 UI/dia no segundo**.

Suplementação de Vitamina A

Em regiões com alta prevalência de hipovitaminose A, como Norte e Nordeste do Brasil, faz-se suplementação entre **seis meses e cinco anos de idade**:

- De seis a onze meses: **100.000 UI a cada seis meses**
- De um a cinco anos: **200.000 UI a cada seis meses**

Resumo dos Gatilhos para Fixação

1. O **aleitamento materno** é recomendado de maneira **exclusiva**, em **livre demanda**, até os **6 meses** de idade, e de maneira **complementar** até no **mínimo 2 anos** de idade.
2. O principal mecanismo que leva a uma boa produção de leite materno é o **estímulo à sucção e esvaziamento** da mama.
3. O principal mecanismo que leva ao aparecimento das **fissuras mamilares** é a **pega inadequada**.
4. A **introdução alimentar** deve ser iniciada aos **seis meses** de idade, sendo ofertados alimentos de **todos os grupos alimentares**, com textura **progressivamente semelhante à da família**, evitando a oferta de alimentos **ultraprocessados**.
5. A suplementação de **vitamina D** deve ser iniciada no **7º dia de vida**, com as seguintes doses:
 - 1º ano: **400 U/dia**
 - 2º ano: **600 U/dia**

6. Suplementação de ferro:

- **RN > 37 semanas e peso ao nascer > 2.500 g:** 1 mg/kg/dia de ferro elementar. Com fatores de risco: dos **3 meses** até os 2 anos; sem fatores de risco: dos **6 meses** até os 2 anos.
- **RN < 37 semanas OU peso ao nascer < 2.500 g:** Iniciada com **1 mês de vida**. No 1º ano de vida a dose depende do peso ao nascer (< 1.000g: 4 mg/kg/dia; 1.000-1.499g: 3 mg/kg/dia; 1.500-2.499g: 2 mg/kg/dia). Do 12º ao 24º mês: 1 mg/kg/dia independente do peso.

Observações Finais

Lembre-se sempre: nossa função como médicos vai além de prescrever. Precisamos **educar, acolher e empoderar** as mães e famílias para que consigam amamentar e alimentar seus filhos da melhor forma possível. O aleitamento materno e a introdução alimentar adequada são pilares fundamentais para o crescimento e desenvolvimento saudáveis da criança, prevenindo doenças no presente e no futuro.

As orientações nutricionais na pediatria não são apenas técnicas: elas envolvem aspectos culturais, emocionais e sociais. Cada família tem sua realidade, e precisamos adaptar nossas orientações de forma individualizada, sempre respeitando e valorizando o contexto de cada binômio mãe-bebê.